

Sphincter Urinaire Artificiel (AUS)

WARWIKI

Information pour le patient · Ce que vous devez savoir avant votre chirurgie

Le sphincter urinaire artificiel (AUS) est un petit dispositif implanté entièrement sous la peau qui rétablit le contrôle de la vessie en cas de fuite urinaire — le plus souvent après une chirurgie de la prostate. Vous le contrôlez vous-même grâce à une pompe dissimulée dans le scrotum. Ce document explique son fonctionnement, comment vous préparer et ce à quoi vous attendre.

À propos de cette intervention

Les fuites urinaires à l'effort, lors d'une toux ou en soulevant un objet constituent une **incontinence urinaire d'effort**, fréquente après une chirurgie de la prostate. L'AUS y remédie grâce à trois composants connectés, tous dissimulés sous la peau :

- Une souple **manchette** autour de l'urètre (le canal par lequel l'urine s'écoule) qui le comprime doucement pour vous maintenir au sec
- Une **pompe** dans le scrotum que vous pressez pour uriner
- Un petit **réservoir** (ballon) dans le bas-ventre qui régule la pression

Comment l'utiliser : normalement, la manchette reste fermée et vous maintient au sec. Pour uriner, pressez et relâchez la pompe quelques fois — la manchette s'ouvre et vous pouvez uriner. Quelques minutes plus tard, elle se regonfle et se referme automatiquement.

Est-ce sans danger ?

L'AUS est le traitement de référence établi pour ce type de fuites, et la plupart des hommes retrouvent un très bon contrôle. Comme tout implant, il comporte quelques risques — principalement l'infection ou l'usure du dispositif ou de l'urètre au fil du temps, pouvant nécessiter une réparation ultérieure. Votre équipe réduit le risque d'infection par des antibiotiques, une technique stérile et le traitement préalable de toute infection urinaire.

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence urinaire d'effort

Fuite d'urine à l'effort, lors d'une toux ou en soulevant un objet.

Urètre

Le canal qui évacue l'urine hors du corps.

Manchette

La partie du dispositif qui comprime doucement l'urètre pour vous maintenir au sec.

Pompe

La partie dans le scrotum que vous pressez pour ouvrir la manchette et uriner.

Activation

Mise en marche du dispositif lors d'une consultation environ 6 semaines après la chirurgie, une fois la cicatrisation obtenue.

Désactivation

Mise à l'arrêt du dispositif (manchette maintenue ouverte) — indispensable avant tout sondage.

Anesthésie générale

Médicament qui vous maintient endormi et sans douleur pendant la chirurgie.

Cystoscopie

Examen de l'urètre et de la vessie par caméra, souvent réalisé avant la chirurgie.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La chirurgie se fait sous anesthésie générale ou rachianesthésie : vous ne sentez rien pendant l'intervention. Ensuite, le scrotum et le périnée sont douloureux, gonflés et marqués d'ecchymoses pendant quelques semaines — suspensoir, glace et antalgiques aident. L'opération dure 1–2 heures ; beaucoup rentrent chez eux le jour même.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Intervention sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — respectez toutes les consignes chirurgicales (jeûne et médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- Un **examen d'urine** recherche une infection — celle-ci doit être traitée avant l'opération, qui pourrait être reportée.
- **Ne fumez pas et n'utilisez pas de cigarette électronique** ; douchez-vous avec le **savon antiseptique** fourni et prenez les antibiotiques prescrits — c'est un implant, la prévention de l'infection est prioritaire.

Signalez à l'avance à votre équipe si vous :

- Avez reçu une **radiothérapie** pelvienne ou subi une chirurgie urétrale ou de l'incontinence
- Êtes diabétique ou avez des difficultés à utiliser vos mains (vous actionnez vous-même la pompe)
- Présentez une infection, où qu'elle soit

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi ou insensibilisé de la taille aux pieds sous anesthésie, et des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Par de petites incisions, le chirurgien place la **manchette** autour de l'urètre, le **réservoir** dans le bas-ventre et la **pompe** dans le scrotum — le tout sous la peau.
- 3 Le dispositif est rempli et testé, puis **laissé désactivé** le temps de la cicatrisation.

Après la chirurgie

- Portez un suspensoir scrotal, appliquez de la glace et évitez **les efforts, la poussée, le vélo et les rapports sexuels** selon les recommandations de votre chirurgien.
- **Le dispositif reste DÉSACTIVÉ environ 6 semaines** : les fuites persistent, gardez des protections (c'est normal). **Ne pressez pas la pompe** avant son activation.
- Vers **6 semaines, le chirurgien active le dispositif** et vous apprend à utiliser la pompe.
- **Informez toujours tout soignant que vous avez un AUS** — il doit être désactivé avant tout sondage, sous peine de blesser l'urètre.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre, des frissons, ou une rougeur, douleur ou écoulement croissant au niveau d'une incision
- Une impossibilité soudaine d'uriner
- Un scrotum très gonflé, dur ou de plus en plus douloureux

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'AUS rétablit le contrôle de la vessie : une manchette vous maintient au sec, et vous pressez une pompe dans le scrotum pour uriner.
2. Il reste **désactivé environ 6 semaines** (les fuites persistent — c'est normal), puis il est activé et vous apprenez à l'utiliser.
3. La prévention de l'infection est primordiale : traitez toute infection, ne fumez pas, utilisez le savon antiseptique et les antibiotiques. **Signalez toujours votre AUS avant tout sondage.**